EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70062
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-08-31 11:49:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS HERNAN CORTES MU◆OZ			RUN	: 5.607.999-8
F.Nac	: 21-08-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-08-21	Fecha Egreso	: 2023-08-31 11:49:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R73.9-HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
1. Abdomen agudo quirúrgico, resuelto:
1.1 Colecisitis aguida gangrenosa (25/08/23)
2. Bacteriemia por E. coli MS, foco urinario
- ITU E. coli MS tratada
3. Sdme. hiperosmolar hiperglicémico, resuelto
4. Lesión renal aguda KDIGO 2, resuelta
5. Trombopenia reactiva resuelta
5. Delirium mixto tratado
6. Trastorno del ánimo - Deterioro cognitivo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. R57.2-CHOQUE SEPTICO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. F05.1-DELIRIO SUPERPUESTO A UN CUADRO DE DEMENCIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. K80.0-CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente diabético sin control ni tratamiento (voluntario), consulta en SU HSC por cuadro de 2 días de evolución, caracterizado por decaimiento, fiebre y CEG. Ingresa en sopor superficial, hiperglicémico (glicemia >500) osmolaridad 414, creatininemia 2,8. Además con orina infecciosa y parámetros inflamatorios aumentados. Con criterios de Sdme. Hiperosmolar, por lo que se hospitaliza en UTI el 21/08 para continuar manejo.
En UTI se inicia BIC de Insulina según protocolo, con reposición hidro-electrolítica, se deja cobertura antibiótica empírica con ceftriaxona tras tomar Cultivos, resultando positivo ambos hemocultivos y Urocultivo para E. coli multisensible, por lo que se mantiene cobertura con ceftriaxona. Presenta evolución favorable, con resolución de Sdme. Hiperosmolar y de su falla renal aguda, actualmente creatininemia 0,8. Con parámetros inflamatorios en descenso. Sin embargo, el día 25/08 amanece con dolor abdominal agudo e intenso asociado a fiebre, se realiza eco abdominal que muestra una colecistitis aguda. Se ingresa a Pabellón ese mismo día, realizándose colecistectomía video-laparoscópica sin incidentes, quedando con un drenaje, el

cual se retira el día 29/08 sin incidentes. Tras este hallazgo, se asocia metronidazol como terapia antimicrobiana asociada. Presenta buena evolución post quirúrgica, tolerando adecuadamente alimentación. Sin fiebre y parámetros inflamatorios en descenso. Completando terapia antibiótica con ceftriaxona por antecedente de bacteriemia.
Sin requerimiento de DVA durante su estadía en UTI, solo manejo con volemización con respuesta favorable. En lo metabólico, una vez resuelta SHH, se inicia NPH, ajustándose dosis en relación a tolerancia alimentaria. Se titula a dosis baja, no presentando hipoglicemias con dosis actual.
En contexto de sepsis, presentó delirium mixto, el cual fue manejado con antipsicóticos, una vez resuelto este conflicto, destaca labilidad emocional y ánimo depresivo, por lo que se inciia Sertralina y se mantiene con quetiapina. En anamnesis familiar dirigida, presenta al menos 2 meses con ánimo bajo, olvidos, celopatía que se exacerba por cuadro infeccioso actual. Actualmente mucho más tranquilo, duerme bien. Queda pendiente evaluación por neurólogo en forma ambulatoria.
Se deriva a HODOM para completar terapia con ceftriaxona (5 dias) y continuar rehabilitación kinésica motora

PLAN DE MANEJO:

Completar tratamiento antibiótico
Evaluacion ambulatoria por neurologia
Ingreso a controles PSCV APS: segun evolución, eventualmente suspender Insulina y dejar Vildagliptina 50 mg c/12 h, idealmente sin metformina.

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen diabético (nutricionista)
2. Ceftriaxona 2gr ev cada 24 hrs (9/14)
3. Omeprazol 20 mg 1 capsula media hora antes del desayuno vo
4. Quetiapina 25 mg 1/2 comprimido en la noche (22:00 hrs) vo
5. Sertralina 50 mg 1 comprimido en la mañana vo
6. Insulina NPH 8 UI am (7:00 hr) - 4 UI noche (22:00 hrs)
7. HODOM: curación herida op, completar antibióticos, rehabilitación motora
8. Al alta: ingresar en programa salud cardiovascular por DM2 en su CESFAM
9. IC neurologia HSC

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorio:
31/08/23: crea 0.8 ELP 136/4,2/106 GB 10600 Hb 9,5 Plt 414 mil PCR 63,3
Ecografia abdominal 25/08/23: colecistitis aguda

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO